

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA				
	FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM						
	Código: IVC-VIG-FM026		Versión: 01		Fecha de Emisión: 05/04/2016		Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE						
Fecha de notificación	Origen del reporte		Nombre de la Institución donde ocurrió el evento	Código PNF		
	Departamento – Municipio					
2023-05-19	SUCRE - MORROA		CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION			
Nombre del Reportante primario	Nombre del Paciente o Acudiente		Consecutivo	Profesión del reportante primario		
Ana Yeimi Sanchez Lozano	PACIENTE		0Rs169u8	ENFERMERA		
Correo electrónico institucional del reportante primario						
asanchez@encontactopeoplemarketing.com						

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE						
Fecha de nacimiento del paciente	Edad del paciente en el momento del EA	Documento de identificación del paciente	Iniciales del paciente	Sexo	Peso	Talla
	Edad – Años/Meses/ días	CC TI RC NUIP Cód. Lab Otro S/I		M F S/I	(Kg)	(cm)
1961-03-30	62	C.C - 18876279	HMMO	M	78	164
Diagnóstico principal y otros diagnósticos:						
CARCINOMA DE CELULAS RENALES						



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS								
Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S” el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.								
S/C/I	Medicamento (Denominación Común Internacional o Nombre genérico)	Indicación	Dosis	Unidad de medida	Vía de administración	Frecuencia de administración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
S	CABOZANTINIB	CARCINOMA DE CELULAS RENALES	60	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	11/04/2023	10/05/2023
S	CABOZANTINIB	CARCINOMA DE CELULAS RENALES	60	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	17/05/2023	ACTUALMENTE
S	DENOSUMAB	MENEJO DE LA OSTEOPOROSIS	120	MG	SUBCUTANEO	CADA 28 DIAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	CARBONATO DE CALCIO	DEFICIENCIA DE CALCIO	600	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	VITAMINA D	DEFICIT DE VITAMINA	200	UI	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	PARACETAMOL	MANEJO DEL DOLO	325	MG	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	TRAMADOL	MANEJO DEL DOLOR	37.5	MG	ORAL	CADA 12 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	ESOMEPRAZOL	PROTECTOR MUCOSA GASTRICA	10	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	HIDROXIDO DE ALUMINIO	MANEJO ACIDEZ GASTRICA	10	ML	ORAL	CADA 8 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	TRAZADONA	INSOMNIO	50	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	ENOXOPARINA	ANTICOAGULANTE	NO INFORMA	UI	SUBCUTANEO	CADA 24 HORAS	17/05/2023	ACTUALMENTE
Información comercial del medicamento sospechoso								
Titular del Registro sanitario			Nombre Comercial		Registro sanitario		Lote	
			CABOMETIX		SIN INFORMACION		SIN INFORMACION	



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO	
Fecha de Inicio del Evento Adverso: 2023-05-17	Evento adverso: INTERRUPCION DE DOSIS POR BARRERAS ADMINISTRATIVAS REINICIO DE TRATAMIENTO HOSPITALIZACION POR DOLOR Y EDEMA DEL BRAZO IZQUIERDO
Descripción y análisis del Evento Adverso: INFORMA PACIENTE QUE LO HOSPITALIZARON EL 17/05/2023 POR PRESENTAR DOLOR Y INFLAMACION DEL BRAZO IZQUIERDO, SE ENCUENTRA EN MANEJO CON ANTICOAGULANTE. ADICIONAL INTERRUPCION DE DOSIS POR BARRERAS ADMINISTRATIVAS DE 7 DIAS REINICIO TRATAMIENTO 17/05/2023	Desenlace del evento (Marcar con una X) Recuperado / Resuelto sin secuelas Recuperado / Resuelto con secuelas ☒ Recuperando / Resolviendo No recuperado / No resuelto Fatal Desconocido Seriedad (Marcar con X) Produjo o prolongó hospitalización Anomalía congénita Amenaza de vida Muerte (Fecha: _____) Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición médica importante Ninguno

	Si	No	No sabe
¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?	X		
¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?	X		
¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?			X
¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?			X
¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?	X		